

Propouštěcí zpráva

Pasztorek Stanislav

Dat. nar.: 17.7.1983

Bydliště: Na Šišťotě 276, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ 75701

Č. poj.: 8307175844
Kód poj.: 213

Hospitalizace od: 19.7.2026

do: 22.7.2026

NVM_INT-ODD2

Chorobopis: 602606390

Přijal(a):

MUDr. Nina Moravcová

RA:

nevýznamná

OA:

Interně závažněji neléčen

- operace tříselné kýly v dětství bilat
Alergie: Pacient(ka) neudává alergii

AA:
EA:

neguje

Návyk:

Kouření: kouřil do cca 2013, nyní ne
Alkohol: 2-3 piva den, tvrdý neguje
Drogy neguje

SPA:

ÚP, stará se o manželku

NO:

43letý pac. přivezen RZP pro nepřímým p.o. pro psychickou zátěž, bolesti břicha
neguje. Zvracení mívá - jen žaludeční šťávy. Průjem neguje. Před 2 dny vyrazili
dveře a sebrali jim děti. Od té doby psychicky na dně, neví co má dělat, suicidální
pokus neguje ale neschopen pro psychické vyčerpání ani vstát z postele. Moči vedle
sebe na koberec. Dle jeho slov se stará o manželku s epilepsií proto je na úřadu
práce. Již při příjezdu počítá s hospitalizací, potřebuje pomoc, doma by nezvládl,
není schopen se o sebe postarat. Psychické problémy by asi měl řešit ale zatím ne.
Lab. elevace JT, GGT 85, bilirubin 77, trombocyty 87, 2,8 promíle. UZ břicha:
hepatopatie, zesílená stěna žlučníku při vs. hepatopatii.

**Objektivní nález
při příjmu:**

Tlak S/D [mmHg]: 140/80, Tep [1/min]: 90, Dech [l/min]: 12, Teplota [°C]: 36.5,
null: 85, null: 175, null: 27.76, Plocha těla [m2]: 2.01, SpO2 [%]: 98

EKG při příjetí:

pac. při vědomí, orientovaný, depresivně laděný, psychicky vyčerpaný, KP komp., AS
pravidelná, rychlá, dýchání sklípkové bílat., bez vedlejších fenoménů, peristaltika
pozitivní, břicho měkké volně prohamtované nebolestivé, bez zn. NPB, DKK bez otoků
AS pravidelná, SR + 4xKES, 99/min, osa -22°, PQ 152 ms, QRS 102 ms, QT 370 ms, T
negat. v aVR, PZ ve V3-4, ST bez denivelací, bez známek akut. ischemie

**Provedená
vyšetření:**

MĚŘENÍ TLAKU KRVĚ:

130/70...140/80...140/90...130/80...130/70...160/100...135/80...130/70...120/70mmHg

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ:

Lab. nález z 19.07.26:

Základní biochemie:

S_UREA: 3,1 mmol/l [2.1 ... 7.1], S_CREA: 63 µmol/l [59 ... 104], PT(KIDN)_CLOCREA:
2,14 ml/s [1 ... 1.5], PT(KIDN)_EGFRCKDE: > 1,50 ml/s/1,73 m2 [1 ... 1.5], S_URAT:
227 µmol/l [202 ... 417], S_NA: 130,4 mmol/l [136 ... 145], S_K: 3,64 mmol/l [3.5
... 5.1], S_CL: 91,7 mmol/l [98 ... 107], S_BIL: 77,8 µmol/l [0 ... 21], S_BILCON:
75,4 µmol/l [0 ... 5], S_ALT: 7,16 µkat/l [0.17 ... 0.83], S_AST: 17,44 µkat/l
[0.17 ... 0.85], S_GGT: 85,98 µkat/l [0.17 ... 1.19], S_ALP: 2,72 µkat/l [0.67 ...
2.15], S_AMS: 0,49 µkat/l [0.47 ... 1.67], S_GLC: 7,9 mmol/l [3.5 ... 5.6], S_CRF:
1,91 mg/l [0 ... 5], S_LPS: 1,44 µkat/l [0.22 ... 1]

Toxikologie:

S_ETOHMS: 2,8 g/l [0 ... 0.2]

Krevní obraz a DIFF:

B_LKC: 6,81 10⁹/l [4 ... 10], B_ERC: 4,55 10¹²/l [4 ... 5.8], B_HB: 143 g/l [135
... 175], B_HCT: 0,392 l [0.4 ... 0.5], ERC(B)_MCV: 86,2 fl [82 ... 98], ERC(B)
_MCH: 31,4 pg [28 ... 34], ERC(B)_MCHC: 365 g/l [320 ... 360], ERC(B)_RDW: 0,130 l
[0.1 ... 0.152], B_PLT: 87 10⁹/l [150 ... 400], PLT(B)_MPV: 9,3 fl [7.8 ... 11],
B_PCT: 0,800 10⁻³ [1.2 ... 3.5], B_NEU: 5,10 10⁹/l [2 ... 7], B_LYMFO: 1,06

Propouštěcí zpráva

Pasztorek Stanislav

Dat. nar.: 17.7.1983

Č. poj.: 8307175844

Bydliště: Na šišťotě 276, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 75701

Kód poj.: 213

Hospitalizace od: 25.7.2026

do: 6.8.2026

NVM_INT-ODD1

Chorobopis: 602606572

Přijal(a): MUDr. Václav Krupa

- přichází pro ikterus, celk. zhoršení stavu, slabost, vyčerpání.

RA: nevýznamná

OA: 7/2026 hosp. INT.ODD.:

- Alkoholová hepatopatie s hyperbilirubinemií, elevací jaterních testů a trombocytopenií
- Psychická dekompenzace při akutní psychosociální zátěži.
- Arteriální hypertenze
- 8/26 alkoholová hepatitida s nutností kortikoter. - obj. disp. GE amb.
- 8/26 při alkoholové hepatitidě zachyt myelocytů, promyelocytů a oj. i blastů v man. diff. ke sledování a příp. vyš. hematologem

AA:

- operace tříselné kýly v dětství bilat.

FA: Alergie: Pacient(ka) neudává alergii

THIAMIN LÉČIVA, TBL NOB, 50MG, 1, tbl, p.o., 1-1-1, NEBERE, NETOLERUJE, má z toho halucinace,

EA: 16, CITALEC, TBL FLM, 10MG, 10, mg, p.o., 1-0-0, Titrace dávky co 2 týdny, neguje

Návyk: Kouření: kouřil do cca 2013, nyní ne

Alkohol: 2-3 piva den, tvrdý neguje

Drogy neguje

ÚP, stará se o manželku

SPA:

NO:

43-letý pacient přichází pro ikterus, celk. zhoršení stavu, slabost, vyčerpání. Před 3 dny propuštěn z int. odd., kde hospitalizován pro alkoholovou hepatopatii s hyperbilií, elevací JT a trombocytopenií, psychotickou reakcí, vstupně byl ethol 2,8 promile. Od té doby se stav zhoršuje, slabý, zpomalený, nepřijímá per os, bolesti hlavy. Výrazná progresivní ikterus. Laboratorně zn. dehydratace, Bilí elevován téměř o dvojnásobek, dnes 282 umol/l, JT v mírném poklesu, elevován amoniak, zn. jaterního selhání, akutní alkoholová hepatitida.

Objektivní nález při příjmu:

Tlak S/D [mmHg]: 140/80, Tep [1/min]: 90, Dech [l/min]: 12, Teplota [°C]: 36.5, null: 85, null: 175, null: 27.76, Plocha těla [m2]: 2.01, SpO2 [%]: 98

Obj. Při vědomí, lucidní, komunikuje, spolupracuje, sotva zvládne chůzi, vyčerpáný, slabý, zn. encefalopatie, orientován však všemi směry, dominuje ikterus kůže, hlava bez zn. traumatu, ameningeální, neurologicky bez lateralizace, zornice izokorické, reagují na osvit správně, sklery výrazně ikterické, AS pravidelná, stří. rychlá, ozvy ohraničené, bez diferenc. šelestů, klid. eupnoe, pulmo auskult. alveolární, bvf., břicho v nivěu, palp. klidné, nebolestivé, bez hm. rezistence, P+, aperit., Murphy negat., TPT bilat. negat., DKK bez otoků, bez klin. zn. TEN.

EKG: AS pravidelná, SR, 89/min, osa -30°, PQ 160 ms, QRS 80 ms, QTc 450 ms, T negat. v aVR, PZ ve V4-5, ST bez denivelací, bez známek akut. ischemie, LAH TK: 120/80...130/100...105/65...115/75...110/70...115/75...120/80...110/75...110/80mmHg

EKG při příjetí:

Provedená vyšetření:

Lab. nález z 25.07.26:

Základní biochemie:

S_UREA: 2,1 mmol/l [2.1 ... 7.1], S_CREA: 58 umol/l [59 ... 104], PT(KIDN)_CLOCREA: 2,35 ml/s [1 ... 1.5], PT(KIDN)_EGFRCKDE: > 1,50 ml/s/1,73 m2 [1 ... 1.5], S_URAT: 146 umol/l [202 ... 417], S_NA: 131,0 (min) mmol/l [136 ... 145], S_K: 4,20 mmol/l [3.5 ... 5.1], S_CL: 97,3 (min) mmol/l [98 ... 107], S_BIL: 281,6 umol/l [0 ... 21],

Propouštěcí zpráva

Dat nar: 17.7.1983

Kod poj: 213

Č poj: 0307175844

Pasztorek Stanislav

K769 Hepatopatie
F329 Depresivní fáze NS - k psych. dovyšetření
E871 Hypoosmolalita a hyponatremie
G934 Encefalopatie NS

Závěr:

- Akutní alkoholová hepatitida, hyperamonémie, hepat. encefalopatie s reskol na terapii kortikoidy

- kont. dysb., dehydratace vstupně při alkohol.hep.

- kontrola u praktického lékaře do 3 dnů s propouštěcí zprávou

- zavedená medikace - viz. níže TABULKA

- režimová opatření: dodržovat dostatečný pitný režim, racionální dietní strava, přiměřená pohybová aktivita dle možnosti.

Doporučení:

- PŘÍSNÁ ABSTINENCE ALKOHOLU!!!

- 27.8.2026 11:00 kontrola na gastroenterologické ambulanci. Týden před vyšetřením se zastavit na GE amb. k odběrům 20.8.nejdříve, 24.8. nejpозději. Odběry jaterní testy, INR, Q, KO + MANUÁLNÍ diferenciál
- Prednison 2-0-0 užívat 4 týdny. Poté dle GE.

- V lab. myelocyty a 5.8. blast - dop. lab. kontrola - při přetrvání hemtologické vyš.

Den	Název	Dávka	Aplikace	Rozpis	Poznámka
	CITALEC, TBL FLM, 10MG	10mg	p.o.	1 - 0 - 0	Titrace dávky co 2 týdny
8.	PREDNISON LÉČIVA, TBL NOB, 20MG	20mg	p.o.	2 - 0 - 0	Nové! (RP) celkem 4 týdny, poté dle GE snižovat
	ESSENTIALE FORTE, CPS DUR, 600MG	600mg	p.o.	1 - 1 - 1	Nové! (RP)
	SIL YMARIN AL, TBL OBD, 50MG *	50mg	p.o.	1 - 1 - 1	Nové! (RP)
	THIAMIN LÉČIVA, TBL NOB, 50MG	1tbl	p.o.	1 - 1 - 1	Nové! (RP)
	URSOSAN FORTE, TBL FLM, 500MG	500mg	p.o.	1 - 0 - 0	Nové! (RP)
	B-komplex	1dávka	p.o.	1 - 0 - 0	Nové! Volně prodejné
	Nutridrink	1dávka	p.o.	1 - 1 - 0	Nové! Volně prodejné

Doprava:

Vlastní

Edukace:

Pacient byl seznámen se svým zdravotním stavem, s navrženým individuálním léčebným postupem, měl možnost položit doplňující otázky a s navrženým postupem souhlasí.

Byla vysáána nosokomiální nákaza? Ne

Byl podepsán souhlas s hospitalizací? Ano

Byl poskytnut transport? Ne

Byla vystavena Dočasná pracovní neschopnost? Ne

Učeno pro:

1x pacient, 1x chorobopis, 1x specialista

Dne 6.8.2026 11:02
První MUDr. Marie Černochová

MUDr. Nina Moravcová

primář oddělení

lékař

94	KEMOTEC AGEL
102	Valašské Meziříčí a.s.
825	Interní oddělení MUDr. Marie Černochové
	U Nemocnice 980, 757 01 MUDr. Nina Moravcová
	tel. 513 128 221

